

ІНСТИТУТ СІРОВАТКИ КРОВІ ІНДІЇ ПВТ. ЛТД.

АДСОРБОВАНА ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ДИФТЕРІЇ, ПРАВЦЯ ТА КАШЛЮКУ

ОПИС

Адсорбовану вакцину для профілактики дифтерії, правця та кашлюку виготовляють шляхом об'єднання очищеного дифтерійного анатоксину, очищеного правцевого анатоксину та інактивованого збудника кашлюку *Bordetella pertussis*. Антигени адсорбуються на алюмінію фосфаті, який використовують в якості ад'юванта. Тіомерсал присутній в якості консерванту. Вакцина має вигляд сірувато-білої суспензії і не містить протеїнів кінської сироватки, тому не викликає сенсibilізації до сироватки кінського походження. Вакцина відповідає вимогам ВООЗ, стандартам Індійської фармакопеї та Європейської фармакопеї при тестуванні за методами, викладеними в ВООЗ, TRS. 980 (2014), Індійській фармакопеї та Європейській фармакопеї.

СКЛАД

Кожна окрема доза для людини по 0,5 мл містить
Дифтерійний анатоксин ≤ 25 флокулюючих одиниць (≥ 30 МО)
Правцевий анатоксин ≥ 5 флокулюючих одиниць (≥ 40 МО)
Інактивованій збудник кашлюку *B. pertussis* ≤ 16 OU (≥ 4 МО)
Адсорбований фосфатом алюмінію, $Al^{+++} \leq 1,25$ мг
Консервант: 0,005% Тіомерсал

ПОКАЗАННЯ

Для первинної імунізації проти дифтерії, правця і кашлюку немовлят у віці старше шести тижнів і дітей дошкільного віку. Вакцину можна безпечно та ефективно застосовувати одночасно з вакцинами БЦЖ, вакцинами для профілактики кору, поліомієліту (ІПВ та ОПВ – інактивованими та оральними), гепатиту В, жовтої гарячки, гемофільної інфекції типу b, вітряної віспи та одночасно з вітаміном А.

ЗАСТОСУВАННЯ І ДОЗУВАННЯ

Для первинної імунізації рекомендується робити щеплення трьома окремими дозами по 0,5 мл з приблизними інтервалами між щепленнями від 4 до 6 тижнів. Першу дозу слід вводити приблизно у віці 6 тижнів. Бустерну дозу 0,5 мл слід вводити через 12 місяців після первинної імунізації, а також у віці від 4 до 6 років.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Вакцину АКДП слід вводити внутрішньом'язово. Переважним місцем ін'єкції є передньолатеральна сторона верхньої частини стегна. (Введення вакцини в сідницю дитини може призвести до пошкодження сідничного нерву, отже, такий спосіб введення не рекомендується). Вакцину не слід вводити внутрішньошкірно, так як це може спричинити місцеву реакцію. Для кожної ін'єкції слід використовувати тільки стерильні голки і шприци. Перед застосуванням добре збовтати вакцину. Після відкриття багатодозові флакони слід зберігати з дотриманням температурного режиму в діапазоні від $+2^{\circ}\text{C}$ до $+8^{\circ}\text{C}$. Багатодозові флакони адсорбованої вакцини проти дифтерії, правця та кашлюку, з яких одна або кілька доз вакцини було взято під час сеансу імунізації, можуть бути використані в наступних сеансах імунізації протягом максимального терміну 28 днів, якщо буде дотримано всіх наступних умов (як описано в Директиві ВООЗ: використання багатодозових флаконів з вакциною після відкриття, WHO/IVB/14.07):

Вакцина наразі є прекваліфікованою ВООЗ;

Вакцину можна використовувати протягом 28 днів після відкриття флакона, згідно з визначенням ВООЗ;

Термін придатності вакцини не минув;

Флакон з вакциною зберігався і зберігатиметься при рекомендованих ВООЗ або виробником температурах; крім того, за наявності флаконного термоіндикатора вакцини на етикетці вакцини, він є видимим і він не вказує на перевищення точки утилізації, і за умови якщо вакцина не була пошкоджена

заморожуванням. Перед введенням, вакцину слід візуально перевірити на наявність будь-яких сторонніх твердих часток та / або на зміну фізичних властивостей. У разі виявлення будь-яких відхилень слід утилізувати вакцину.

Як використовувати ДПК вакцину виробництва Інституту сироватки крові Індії (ISCI) та вакцину проти Hib-інфекції виробництва (ISCI) як чотиривалентну.

ДПК вакцина виробництва ISCI може використовуватися для відновлення вакцини проти Hib інфекції (ISCI) для одночасного введення у вигляді одноразової ін'єкції. Вакцину проти Hib (ISCI) відновлюють наступним чином: додають повний вміст ампули ДПК вакцини (ISCI) або 0,5 мл з багатодозового флакона ДПК вакцини (ISCI). Після додавання ДПК (ISCI) до гранул (ліофілізованої маси) вакцини проти Hib, суміш слід ретельно струсити до повного розчинення гранул Hib в суспензії ДПК вакцини (виробництва ISCI). Після відновлення комбінована вакцина повинна бути негайно введена. Ввести суспензію 0,5 мл шляхом внутрішньом'язової ін'єкції.

ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ

Поширені незначні місцеві або системні реакції. В багатьох випадках спостерігаються тимчасові незначні набряки, чутливість і почервоніння в місці ін'єкції, що супроводжуються лихоманкою. В деяких випадках протягом 24 годин розвиваються важкі реакції що супроводжуються високою температурою тіла, дратівливістю та плачем. Було зафіксовано випадки розвитку гіпотонічно-гіпореактивних епізодів. Повідомлялося про фебрильні судоми з частотою один випадок на 12500 введених доз. Прийом парацетамолу під час та через 4-8 годин після імунізації знижує подальшу частоту виникнення фебрильних реакцій. Національне дослідження дитячої енцефалопатії у Сполученому Королівстві показало незначний підвищений ризик розвитку гострої енцефалопатії (насамперед судом) після імунізації вакциною АКДП. Однак наступні детальні огляди всіх наявних досліджень ряду груп, включаючи Інститут медицини США, Консультативний комітет з практики імунізації та педіатричні асоціації Австралії, Канади, Сполученого Королівства та США, дійшли висновку, що дані досліджень не встановили наявності причинно-наслідкового зв'язку між вакцинацією АКДП та хронічною дисфункцією нервової системи у дітей. Таким чином, немає наукових доказів того, що гіпотонічно-гіпореактивних епізоди та фебрильні судоми мають будь-які незворотні наслідки для дітей.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

ІН'ЄКЦІЯ АДРЕНАЛІНУ (1:1000) ПОВИННА БУТИ ДОСТУПНА ДЛЯ НЕГАЙНОГО ВВЕДЕННЯ В РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ГОСТРОЇ АНАФІЛАКТИЧНОЇ РЕАКЦІЇ ЧЕРЕЗ БУДЬ-ЯКИЙ КОМПОНЕНТ ВАКЦИНИ. Для лікування важкої анафілаксії початкова доза адреналіну становить 0,1-0,5 мг (0,1-0,5 мл ін'єкції 1:1000), вводиться підшкірно або внутрішньом'язово. Разова доза не повинна перевищувати 1 мг (1 мл). Для немовлят і дітей рекомендована доза адреналіну становить 0,01 мг/кг (0,01 мл/кг ін'єкції 1:1000). Разова дитяча доза не повинна перевищувати 0,5 мг (0,5 мл). Основою при лікуванні важкої анафілаксії є оперативне використання адреналіну, який може врятувати життя. Його слід використовувати при першій підозрі на анафілаксію. Так само як і при використанні всіх інших вакцин, вакцинований повинен залишатися під наглядом після вакцинації не менше 30 хвилин для спостереження щодо можливості виникнення негайних або ранніх алергічних реакцій. Гідрокортизон і антигістамінні препарати також повинні бути доступні на додаток до допоміжних заходів, таких як киснева інгаляція. Особливу увагу слід приділити тому, щоб ін'єкція не була введена в кровоносну судину.

НАДЗВИЧАЙНО ВАЖЛИВО, ЩОБ КОЛИ ОДИН З БАТЬКІВ ЧИ ОПІКУНІВ ДИТИНИ АБО ДОРΟΣЛИЙ ПАЦІЄНТ ПОВЕРТАЮТЬСЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ НАСТУПНОЇ ДОЗИ ВАКЦИНИ, БАТЬКО (МАТИ), ОПІКУН АБО ДОРΟΣЛИЙ ПАЦІЄНТ МАЮТЬ БУТИ ОПИТАНІ ЩОДО ВИНИКНЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ СИМПТОМІВ ТА/АБО ОЗНАК ПОБІЧНОЇ РЕАКЦІЇ ПІСЛЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ДОЗИ.

ВЗАЄМОДІЯ З ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ

Якщо одночасно вводять вакцину КДП та правцевий або дифтерійний антитоксин, слід використовувати окремі шприци та окремі ділянки тіла для проведення щеплення.

Як і з іншими внутрішньом'язовими ін'єкціями, застосовувати з обережністю у хворих які отримують антикоагулянтну терапію. Імуносупресивна терапія, включаючи опромінення, антиметаболіти, алкілюючі засоби, цитотоксичні препарати та кортикостероїди, що перевищують

фізіологічні дози, може зменшити імунну відповідь на вакцини.

ПРОТИПОКАЗАННЯ І ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація про гіперчутливість до будь-якого компоненту вакцини або важку реакцію на попередню дозу вакцини, або будь-яку з її складових, є абсолютним протипоказанням до введення наступних доз вакцини або конкретної вакцини, яка, як відомо, спровокувала побічну реакцію. Існує невелика кількість протипоказань для першої дози АКДП – судоми або аномальні церебральні ознаки у немовлят або інші серйозні неврологічні аномалії є протипоказаннями до кашлюкового компонента. При цьому замість вакцини ДПК слід вводити вакцину ДП.

Строки імунізації слід відкласти, якщо у немовляти гостре захворювання. Однак субфебрильну температуру, легкі респіраторні інфекції, недоїдання або діарею не слід розглядати як протипоказання. Немовлятам, які мають неврологічні захворювання в стадії загострення або прогресуючі неврологічні захворювання, включаючи недавні судоми, не слід вводити вакцини, що містять кашлюковий компонент. Натомість слід використовувати для вакцинації адсорбовану вакцину ДП. Другу або наступну дозу вакцини КДП не слід вводити дитині, яка мала важку реакцію на попередню дозу, таку як стійкий плач, шок, судоми або енцефалопатія.

ІМУНОДЕФІЦИТ

Особи, інфіковані вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), як безсимптомні так із симптоматичними проявами, повинні бути імунізовані вакциною КДП за стандартними графіками.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ВАКЦИНИ

Вакцину слід зберігати при температурі від 2°C до 8°C. Транспортувати вакцину слід також при температурі від 2°C до 8°C. НЕ ЗАМОРОЖУВАТИ.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

24 місяці з дати виробництва.

ФОРМА ВИПУСКА

1 доза в ампулі 0,5 мл

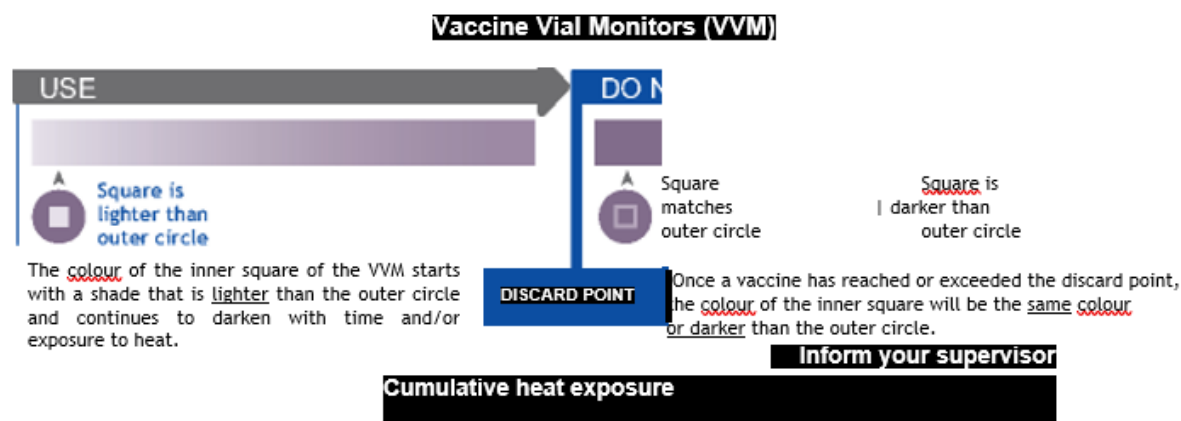
2 дози в ампулі/флаконі 1 мл

10 доз у флаконі 5 мл

20 доз у флаконі 10 мл

Флаконний термоіндикатор (не обов'язково)

Рис. Флаконний термоіндикатор (Vaccine Vial Monitor)



Оригінал	Переклад
Use	Можна використовувати
Square is lighter than outer circle	Колір квадрату світліший за колір зовнішнього кола.
The color of the inner circle of the VVM starts with a shade that is lighter than the outer circle and continues to darken with time and/or exposure to heat.	Колір внутрішньої частини ФТІ починається з відтінку, який є світлішим за колір зовнішнього кола, він продовжує темніти з часом та/або під дією тепла.
Do not use	Не можна використовувати
Square matches outer circle	Колір квадрату такий самий, як і колір зовнішнього кола
Square is darker than outer circle	Колір квадрату темніший за колір зовнішнього кола
Discard point	Точка утилізації
Once a vaccine has reached or exceeded this discard point, the color of the inner circle will be the same color or darker than the outer circle.	Після того, як вакцина досягне або перевищить точку утилізації, колір внутрішньої частини буде таким самим або темнішим за колір зовнішнього кола.
Inform your supervisor	Проінформуйте свого керівника
Cumulative heat exposure	Сукупний вплив тепла

Флакони термоіндикатори (ФТІ) є частиною етикетки адсорбованої вакцини для профілактики дифтерії, правця та кашлюку, що поставляється через Інститут Сироватки Крові Індії Пвт. Лтд. (Serum Institute of India Pvt. Ltd.). ФТІ – це кольорове коло на етикетці флакона. Це чутливий до дії тепла часово-температурний індикатор, який вказує на сукупну дію тепла на флакон. Він попереджає кінцевого споживача про те, коли дія тепла могла змінити якість вакцини до неприйнятного для використання вакцини рівня. Інтерпретація показників ФТІ проста. Зосередьтеся на центральному квадраті. Його колір буде поступово змінюватися. Поки колір цього квадрату світліший, ніж колір зовнішнього кола, вакцину можна використовувати. Як тільки колір центрального квадрату буде такого ж кольору, як зовнішнє коло, або темнішого кольору, ніж зовнішнє коло, флакон слід утилізувати.

Остання редакція: 02/2020

Виробник:
ІНСТИТУТ СИРОВАТКИ КРОВІ ІНДІЇ ПВТ. ЛТД.
212/2, Хадапсар, Пуне 411028, ІНДІЯ
Захист з моменту народження

(SERUM INSTITUTE OF INDIA PVT. LTD.
212/2, Hadapsar, Pune 411028, INDIA
Protection from birth onwards)

Причина випуска: оновлена версія тексту	Специфікація: надруковано на тонкому папері щільністю 40 г/м2
Замовник: ВООЗ/ЮНІСЕФ/РАНО	
Продукт - Адсорбована вакцина для профілактики дифтерії, правця та кашлюку	
Колір:  та Pantone 072C	
Код товару: 20012703/2 Номер специфікації.: Масштаб макету: 100%	
Замінює код товару 20012703/1	Розміри: 353 x 247 мм

РОЗРОБКА УПАКОВКИ	КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ	РЕГУЛЯТОРНІ ПИТАННЯ	МЕДИЧНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ
-------------------	-----------------	---------------------	----------------------	---------------------

Текст іспанською мовою